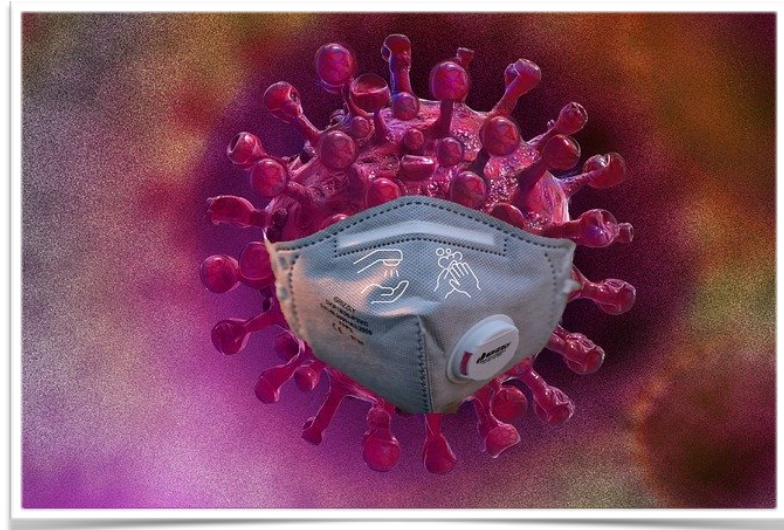




Covid19 : la gestion de crise en question

L'analyse détaillée des décisions publiques depuis le début de 2020 jusqu'à aujourd'hui met en évidence une succession de phases assez caractéristiques.

Grossièrement il y a l'avant confinement, le confinement, et l'après confinement, mais cette différenciation est aussi celle des attitudes et des discours.

Il semble utile de revenir sur les faits, puis de tenter d'en analyser et d'en comprendre la logique.

Les faits

Prise de conscience hésitante

L'identification concrète du virus (Sars-Cov2) intervient en effet mis janvier. Point de départ donc de la « prise de conscience ».

Mais prise de conscience de quoi ?

Des mesures techniques sont prises. En France on désigne 16 hôpitaux « de prise en charge », et un protocole de test est publié par l'OMS (17 janvier).

Mais quelle image a-t-on du problème ou du risque ?

1. La Ministre semble le 20 janvier considérer « Le risque d'introduction (du virus) en France » comme « *faible mais ne peut pas être exclu* ».

2. 4 jours plus tard, on constate l'existence de 3 cas « importés » en France.

A à ce moment on a probablement une vision « floue » et changeante de l'épidémie, A. Buzin nous semblant mal interpréter les résultats de certains modèles. Les probabilités annoncées sont faibles... mais le risque est finalement très élevé. Les propos même des chercheurs auraient sans doute dû altérer l'optimisme ministériel (réel ou simulé ?). (« *As at 27 January 2020, 42 novel coronavirus (2019-nCoV) cases were confirmed outside China. We estimate the risk of case importation to Europe from affected areas in China via air travel. We consider travel restrictions in place, three reported cases in France, one in Germany. Estimated risk in Europe remains high. The United Kingdom, Germany and France are at highest risk. Importation from Beijing and Shanghai would lead to higher and widespread risk for Europe.* »).

La seconde quinzaine de janvier est intéressante. Il s'installe une sorte de préparation (réunions, structures) dans le déni. « *Nous avons des masques* » dit-on, mais *aucun plan réel* n'est déclenché. On rapatrie fin janvier les français de Wuhan (de manière « inégale » dans l'Oise et à Marseille) et l'espace Schengen se ferme à la Chine (sauf la France).

Mi février on constate le premier mort dans un contexte où, semble-t-il on prend conscience des difficultés logistiques qui ne manqueront pas de se poser (dépendance à la Chine, disparition des stocks stratégiques de masques etc.), tandis que des urgentistes s'inquiètent des capacités hospitalières à faire face à une épidémie. A la fin de la quinzaine, A. Buzin quitte le Ministère pour participer aux élections municipales à Paris.

Olivier Veran, nouveau Ministre, déclenche le plan ORSAN (Reb) le 23 février... tout en tenant des discours rassurants. Pratiquement entre la fin février et la mi mars, l'épidémie se développe en France, et le gouvernement commence à prendre des mesures restrictives. Celles-ci sont justifiées par la volonté

de peser sur le pente de la courbe des cas (graves) en limitant le fameux coefficient de reproduction. L'idée est d'aplatir la courbe en cloche traditionnelle de l'épidémie, pour ne pas saturer le système de santé.

Un Conseil scientifique Covid-19 est créé le 10 mars.

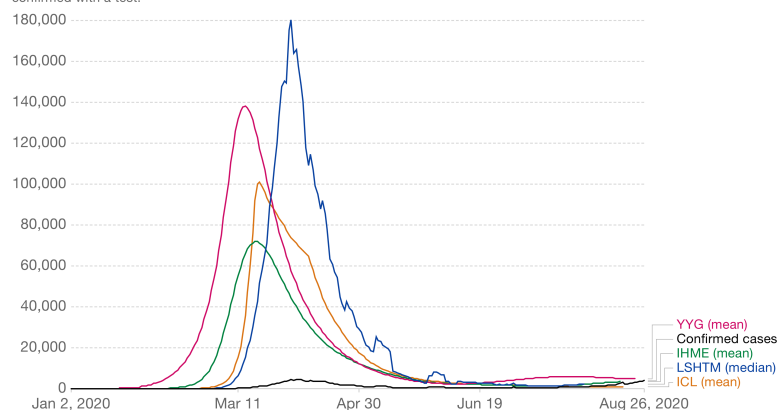
C'est à ce moment que l'on commence à parler des travaux de l'Imperial College de Londres (qui sortira le 30 mars) : « *Estimating the number of infections and the impact of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries* », dont on sait qu'ils anticipaient un nombre de personnes infectées (et de morts) considérable. Mais c'est une approche mécaniste plus ou moins fine.

Graphes des infections au Covid19 selon les chiffres « réels » français et ceux estimés par les modèles :

- Imperial College London (ICL)
- The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
- Youyang Gu (YYG)
- The London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM)

Daily new estimated infections of COVID-19, France

Mean estimates from epidemiological models of the true number of infections. Estimates differ because the models differ in data used and assumptions made. For comparison, confirmed cases are infections that have been confirmed with a test.



Source: ICL (2020), IHME (2020), YYG (2020), LSHTM (2020), ECDC (2020)

Note: This chart shows the latest available model estimates as of 23 August 2020. The uncertainty range for each estimate is not shown here but can be found in the individual model charts.

OurWorldInData.org/covid-models • CC BY

Politique par défaut ?

La politique qui consisterait à tester, isoler les malades et les soigner le mieux possible le plus tôt possible n'est pas retenue. On préfère l'isolement des Ehpad, la limitation des flux hospitaliers aux seuls cas graves, et l'absence de mobilisation des médecins libéraux.

Ce choix politique est fondamental. Il sera par la suite contesté et relié au fort taux de surmortalité enregistré.

Il est vrai qu'à ce moment, la France ne dispose pas des moyens de test nécessaires, et refuse par exemple de répondre à certaines propositions (vétérinaires..).

Dans le même temps, on maintient les élections municipales (15 mars), puis dans la foulée on décrète le confinement (17 mars midi). Notons au passage que cette absence de tests massifs biaise alors considérablement la vision « statistique » de l'épidémie. A ce stade les pouvoirs publics se concentrent sur les cas graves (hospitalisés), les personnes en réanimation, les décès et les guéris qui sont commentés chaque soir à la télévision.

Nous terminons donc la première séquence du processus décisionnel sur une tonalité une nouvelle fois contradictoire en raison de la communication des pouvoirs publics (autour des masques, des élections, ...)

Essayons d'y voir plus clair.

Comme de nombreuses personnes l'expliquent (cf le président du Conseil Scientifique) la stratégie choisie et mise en oeuvre est prise *par défaut* (manque de tests et de masques).

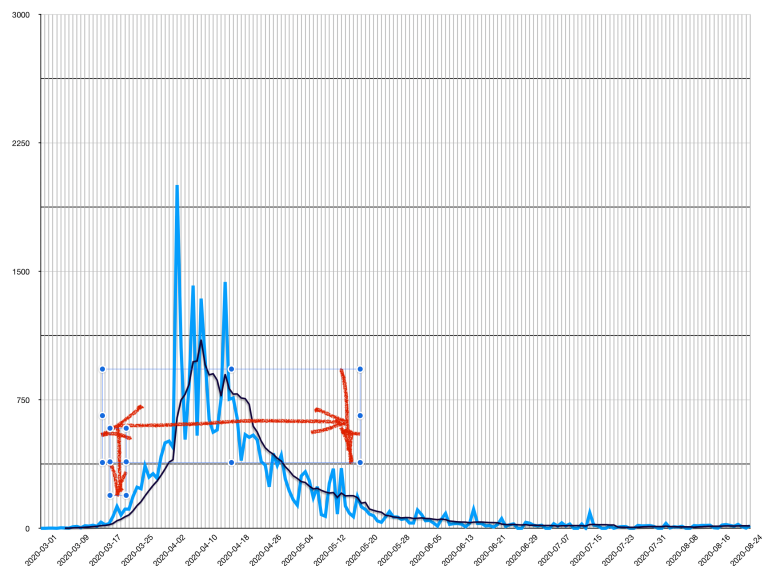
Par ailleurs, on commence alors à avoir des indications sur les stratégies de soin possibles, en particulier via l'IHU de Marseille et les équipes chinoises (voir par exemple : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920301319>). Enfin, certains choix opérés - confinement et absence de tests et de traitement des malades non graves - aboutit alors sans doute à une majoration des décès, singulièrement en Ehpad. Décès ignorés statistiquement dans un premier temps.

Dans le même temps les courbes commencent à s'affoler. Aucune décision n'est prise alors pour produire des connaissances statistiques régulières sur l'épidémie, l'Etat se contentant des seuls indicateurs hospitaliers et de mortalité.

La courbe des décès journaliers continue de croître et atteint son maximum pendant le confinement (zone marquée en rouge sur le graphe ci-après).

En fait il est probable que le confinement a pu avoir un effet, en diminuant mécaniquement le coefficient (R_0) de reproduction. Certaines études tendent à le montrer

Graphe représentatif des décès journaliers dus au Covid19 (et moyenne mobile sur 7 jours) à partir du 1 mars 2020



Il reste que certaines études indiquent que les personnes en télétravail ont plus fréquemment été contaminées que les personnes travaillant à l'extérieur de leur domicile (Etude Espagnole voir : <https://portalcne.isciii.es/enecovid19/>).

Dans le même temps, la France a choisi - parallèlement - de se lancer dans des recherches traditionnelles dont les résultats ne peuvent être compatibles avec l'urgence, et à les organiser en ignorant largement (voir en les combattant) les travaux de l'IHU de Marseille (voir : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297520300664>).

C'est dans cette période que les postures des différents milieux scientifiques mondiaux et des politiques vont se crispier et se radicaliser, et donc se politiser.

On assiste à la publication des études fortement biaisées sur l'Hydroxychloroquine (Recovery) et celle, par le Lancet, de la fameuse étude, retirée depuis, réalisée sur la base du prétendu Big-Data de Surgisphère. Or ce travail a créé un prétexte pour

l'OMS et le Ministre français pour interdire l'hydroxychloroquine.

L'OMS met fin en effet le 4 juillet « *aux volets hydroxychloroquine et lopinavir/ritonavir de l'essai Solidarity* »

A ce stade, et durant des semaines (de mai à Août) on a assisté à l'irruption d'une logique totalement irrationnelle, opposant à la médecine efficace (jusqu'à la preuve du contraire) de par le monde, aux « méthodologistes ». Et certains gouvernements se sont laissés prendre dans ce conflit irrationnel, au lieu de s'en remettre aux données statistiques de soin. Un exemple manifeste, de mon point de vue, de ce mouvement irrationnel peut-être trouvé dans un article « scientifique » publié fin Aout 2020. Il s'agit d'une article sensé répondre à la question de l'efficacité (et de la dangerosité éventuelle) de l'hydroxychloroquine et de l'Azithromycine (Fiolet T, Guibur A, Rebeaud M, Mulot M, Peiffer-Smadja N, Mahamat-Saleh Y, *Effect of hydroxychloroquine with or without azithromycin on the mortality of COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis, Clinical Microbiology and Infection*)

L'article, rédigé en particulier par plusieurs chercheurs liés à l'Inserm, présente une « meta-analyse » des articles publiés et en tire finalement deux conclusions : l'hydroxychloroquine ne fait baisser la mortalité, et son usage avec l'azithromycine augmente la mortalité. Le principal problème de cette étude (en dehors de son interprétation statistique discutable), c'est qu'elle ne prend pas en compte l'absence ou l'hétérogénéité des informations fournies par les études utilisées en ce qui concerne la gravité de la maladie au moment du traitement des patients, la durée des traitements, et l'hétérogénéité des posologies (inconnue dans 42 % des cas), l'absence même de données précises (sans parler des résultats de Recovery portant sur des doses anormalement élevées d'HCQ. Ces limites sont d'ailleurs citées par les auteurs, mais ils n'en tirent pas de conclusion.

Il est difficile de comprendre ce qui amène la publication d'un tel article, si ce n'est la volonté de prendre le contre-pied de l'IHU. Il reste que déniaient toute valeur à l'approche de l'IHU (qui traiterait des malades « qui de toutes façons guériraient », Nathan Pfeiffer-Smadja, interview Huffington Post), il s'agit bien de démontrer l'inefficacité du traitement préconisé et mis en oeuvre par cet institut, même en prenant des libertés méthodologiques considérables, en particulier en

négligeant finalement la nature réelle des soins. Un parti pris qui est symptomatique d'une réelle crise de la recherche médicale (ici non pas médicale mais statistique, finalement), et de l'approche rationnelle de la pandémie.

Ce récit nous amène à nous interroger. Comment en est-on arrivés à une telle situation s'éloignant tout à la fois d'un débat scientifique serein (apaisé) et d'une politique de santé cohérente.

Comment en est-on arrivés là ?

La question n'est pas secondaire dans la mesure où les décisions prises pourraient être à l'origine de la mortalité hospitalière élevée de même que celle dans les Ehpad, supérieure en France à celle relevée dans de nombreux pays.

Il y a eu d'abord, dans l'urgence, le constat d'une impréparation doublée de l'abandon d'une politique de précaution. La lecture des documents officiels du ministère de la Santé (Jaune budgétaire pour les programmes, contrat d'objectifs avec Santé Publique France, Plan stratégique de la Direction Générale de la Santé) laisse clairement apparaître une impréparation doublée d'une absence de doctrine.

On apprend même que sur la question des stocks stratégiques, Santé publique France, devait remettre des rapports en 2020 et 2022. En outre un avis d'expert sur les « *contre-mesures médicales face à une pandémie grippale* » laisse apparaître des doutes sur l'intérêt des masques pour la population. Bref, c'est flou.

Ces déficiences, comme la pénurie de tests, expliquent la communication d'alors. Il serait inefficace en effet de dire « *on s'est mal préparés, on doute de l'utilité des masques, et on n'a pas de tests* ». Comme par ailleurs l'objectif majeur était d'éviter l'engorgement hospitalier (sans mobiliser d'ailleurs les structures privées, sans explication d'ailleurs) on a donc délibérément décidé de demander aux malades de rester chez eux tant qu'ils pouvaient respirer normalement. Ce qui a sans doute d'ailleurs contribué à l'évolution de l'épidémie et de la mortalité. Ce n'est donc pas une stratégie qui a été mise en oeuvre, mais on a communiqué sur une pseudo-rationalisation de décisions perçues comme largement contraintes.

Retour sur le processus de
décision

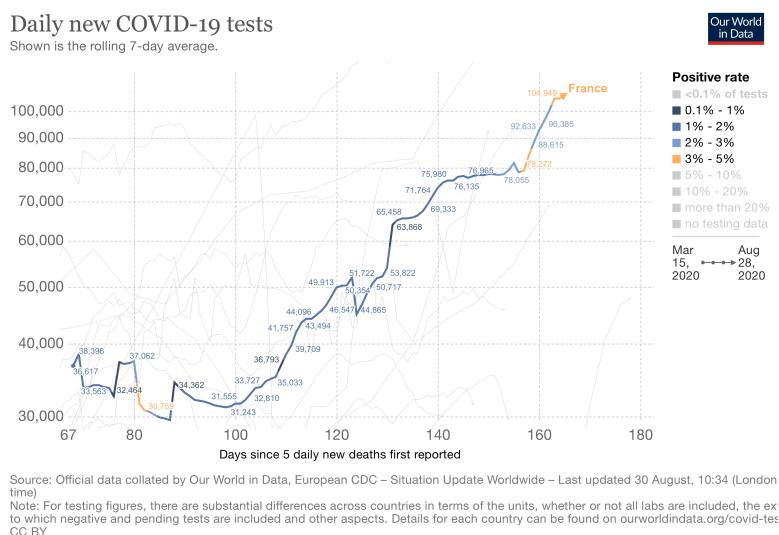
Du coup, certaines décisions sont alors largement incompréhensibles comme cette « chasse » aux baigneurs en mer, ou aux promeneurs (à pied !) à plus d'un kilomètre de chez soi pendant le confinement. A ce stade on peut craindre que la mesure visait non pas à être « efficace » mais à stigmatiser ceux qui pourraient vivre ou vivaient mieux que d'autres le confinement.

L'inversion de la courbe épidémique, puis le retour à un nombre de cas avéré comparable à celui de la mi mars conduit donc au déconfinement après 2 mois.

Théoriquement, ce déconfinement comprend des mesures maintenues de distanciation sociale, et une politique systématique de test. Une fois encore le principe une fois énoncé, il a fallu mettre les pratiques en accord avec les objectifs. Il faut du temps...

Le nombre de test augmente lentement à partir du déconfinement pour atteindre autour de 1,4 test pour 1000 habitants.

Nombre de tests quotidiens (moyenne mobile 7 jours)



Les tests pratiqués changent la perception de la pandémie

Ce niveau est plutôt modéré, et répond à des stratégies disparates sur le sol national, au grès des cas détectés, et des campagnes de dépistage organisées.

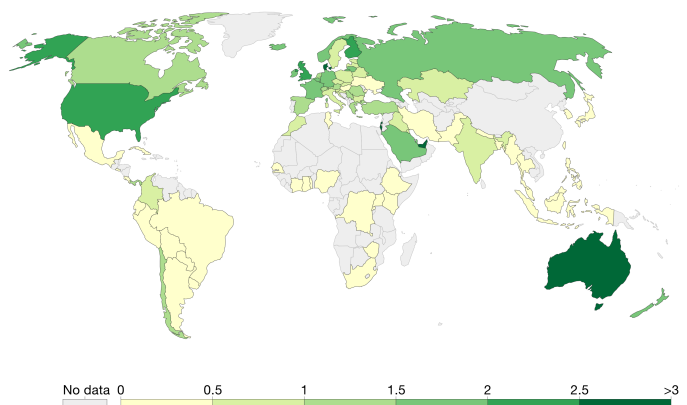
Il se produit alors un mécanisme singulier. La mise en oeuvre de la politique de test doublée du déconfinement, aboutit mécaniquement à une augmentation du nombre de cas positif,

et une certaine augmentation du taux de positivité des personnes testées. Sans qu'il soit d'ailleurs possible de déterminer toujours le degré de représentativité des populations testées. La proportion des diverses tranches d'âge par exemple est loin d'être toujours homogène. En outre la communication journalière de chiffres par construction variables (aléas) contribue à troubler les messages.

Carte mondiale de l'importance des tests (pour 1000 habitants) fin Août 2020

Daily COVID-19 tests per thousand people, Aug 28, 2020

The figures are given as a rolling 7-day average.



Source: Official data collated by Our World in Data
 Note: Comparisons of testing data across countries are affected by differences in the way the data are reported. Daily data is interpolated for countries not reporting testing data on a daily basis. Details can be found at our Testing Dataset page.

S'installe donc à ce moment une communication fondée sur ces chiffres (difficiles à interpréter), justifiant parfois des mesures réglementaires (port du masque en ville...) sans analyse plus poussée (gravité, létalité, etc..). Or nous sommes manifestement entrés dans une nouvelle phase de l'épidémie qu'il conviendrait de comprendre.

Et les soins ?

On a alors l'impression que la question majeure demeure de « contenir l'épidémie » (puisqu'on ne croit pas savoir si elle a changé ou non de nature), et d'éviter à nouveau l'évolution relevée de mars à mai.

Mais on a changé radicalement de discours. On menace de confinement, on prône et rend obligatoire le port du masque dans certains lieux ou certaines agglomérations, et on teste (sans dire qui et comment), sur fonds de discours responsabilisant (culpabilisant ?) autour de la distanciation sociale. Et on insiste largement plus sur le « *masque partout* » que sur les mains et leur hygiène.

Or à ce moment, se pose naturellement à nouveau la question de la stratégie de soins. Ce que souligne indirectement ou implicitement la conférence de presse du D. Raoult du 27 Août.

Du 15/06/2020 au 25/08/2020	Nombre de nouveaux patients positifs à SARS-CoV-2 hospitalisés	Nombre de nouveaux patients positifs à SARS-CoV-2 admis en réanimation	Nombre de décès liés au COVID-19
Paris (pop de 2 148 271 hab.)	456	112 (24.6%)	72 (15.8%)
Bouches-du-Rhône (pop de 2 034 469 hab.)	483	49 (10.1%)	39 (8.1%)

Fichier du 25/08/2020 19h

Sources : Data.gouv <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-hospitalieres-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/#>

« Les données hospitalières quotidiennes relatives à l'épidémie du COVID-19 par département du patient : nombre quotidien de personnes nouvellement hospitalisées, nombre quotidien de nouvelles admissions en réanimation, nombre quotidien de personnes nouvellement décédées. »

Pour quelle raison en effet, les malades meurent-ils plus à Paris ? Est-ce toujours avéré ? Pour quelle raison ne tient-on pas compte des résultats positifs enregistrés à Marseille ou à Garches comme dans de nombreux pays ayant préconisé le même traitement que l'IHU ?

Pour quelle raison, parallèlement, cette dramatisation croissante du discours ?

La seule explication crédible découle d'un triple constat :

- en premier lieu le gouvernement a peur, et n'a pas (ce qui n'est pas anormal) de perception claire de ce qu'il peut advenir. Donc il se concentre sur le nombre de cas, indicateur (moteur) même de sa peur.
- en second lieu il prend, pour se rassurer, des mesures de précaution (masques, horaires de fermeture des restaurants...) ; « *il aura fait ce qu'il pouvait !* ». Il ne peut ignorer cependant que certaines mesures sont illusoires (port du masque généralisé dans les rues...)
- enfin le pouvoir exécutif n'ose toujours pas, pour des raisons idéologiques, s'en remettre à une approche pragmatique et donc à une politique de soin, et attend, comme l'a dit le Premier Ministre, « *que Veran découvre un vaccin* », autrement dit on attend le salut de la vaccination et non du soin.

Cette situation singulière qui fait office de politique a une rationalité interne visible, mais débouche clairement sur un sentiment partagé d'incohérence, et de « *mauvaise politique de*

santé ». On parle de plus en plus de gestion bureaucratique discutée par ailleurs en droit (Jean Quatremer).

Cette situation, qui risque de s'aggraver à la rentrée, n'enlève rien à l'incertitude normale face à une pandémie inédite, mais brouille un peu plus la perception de la politique menée. La somme des contradictions passées et la volonté de ne pas laisser penser que des soins sont possibles et efficaces sont anxiogènes, tout en livrant une image du monde médical pitoyable. Il ne reste que les masques, jadis moqués. Or tout se déroule dans un contexte d'affrontement au sein du milieu médical. Qui pensait (en dehors du milieu médical sans doute) que de tels affrontements puissent exister, et que de telles oppositions de principe puissent s'y exprimer ? Jusqu'à devenir un objet banalement politique. C'est où la médecine rejoint finalement les autres « disciplines scientifiques » et singulièrement les sciences humaines.

Resteront les faits et les données. Espérons qu'on en tirera des conclusions utiles.

P.S.